



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA TIM PKBRS
PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Dasar Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

BAB II GAMBARAN UMUM 6

2.1 Visi..... 6

2.2 Misi 6

2.3 Motto..... 6

2.4 7 Nilai Budi Utama 6

2.5 SOTK..... 7

BAB III KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI 8

3.1 SDM..... 8

3.2 Pengembangan Pelayanan..... 10

3.3 Kinerja Produktifitas 12

3.4 Fasilitas Kesehatan 18

3.5 Mutu..... 22

3.6 Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan..... 27

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI..... 28

BAB IV PENUTUP 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Prima Husada adalah sebuah Rumah Sakit Swasta tipe C yang terletak di Banjararum Selatan, Singosari, Malang. Rumah sakit berperan sebagai ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat, harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Rumah sakit harus mengacu pada prinsip – prinsip akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi.

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit harus berlandaskan peraturan dan undang undang yang berlaku, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perumahan sakitan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
3. Undang – Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas

-
- Rumah Sakit
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Tujuan penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit Prima Husada Malang 2025 adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit
3. Menetapkan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 Misi

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

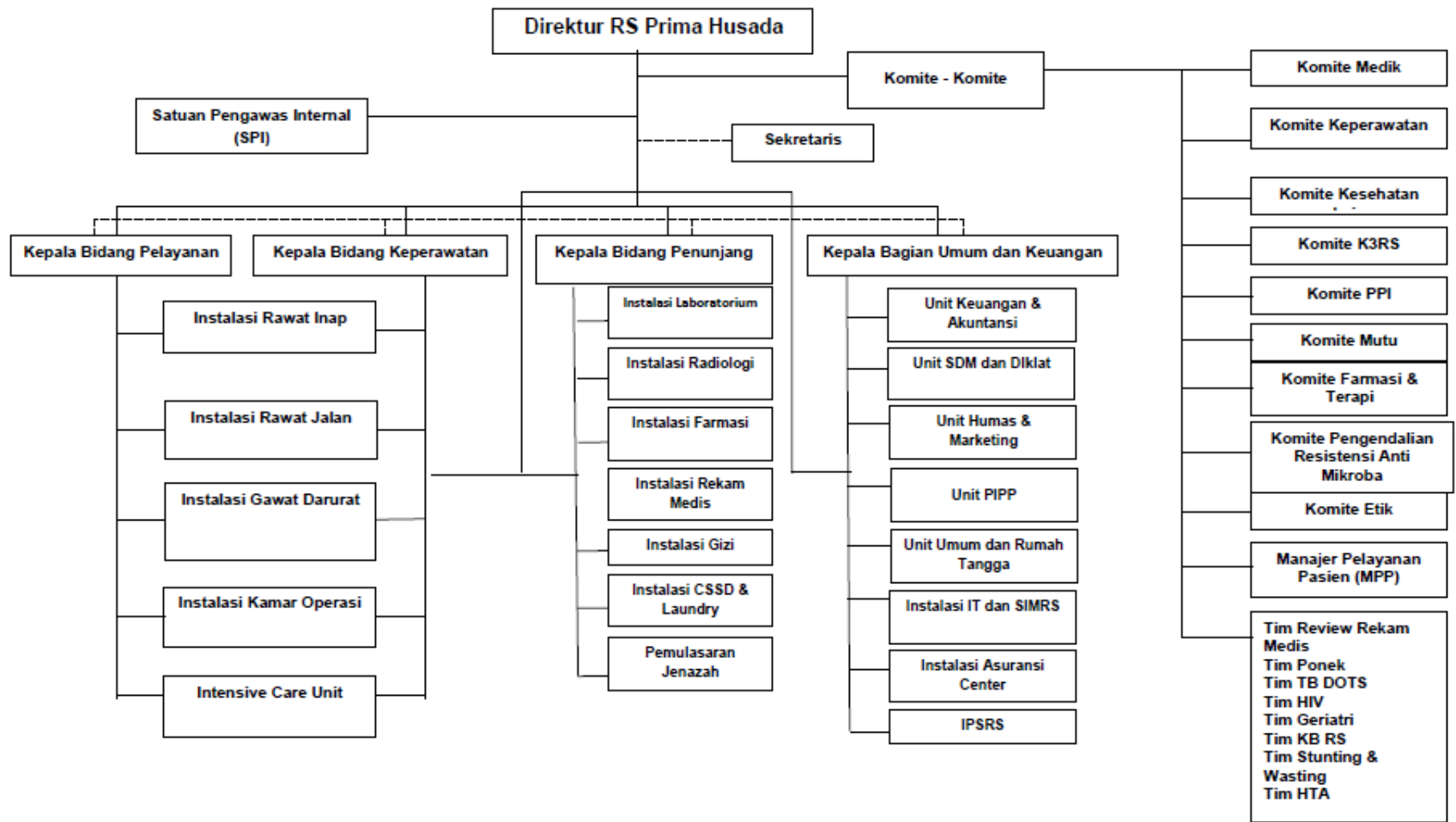
2.3 Motto

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK



BAB III

KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 SDM

3.1.1 Ketenagaan

Jabatan	Jumlah SDM												
	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	Nov	Des
Ketua Tim PKBRS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sekretaris Tim PKBRS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anggota Tim PKBRS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Jabatan	Pendidikan	jumlah
	Standar	
Ketua Tim PKBRS	Dokter	1
Sekretaris	Bidan	1
Anggota tim	Bidan	3

3.1.2 Analisis

a. Kondisi SDM :

Jumlah Tim PKBRS secara keseluruhan adalah berjumlah 5 orang. Masing-masing anggota memegang jabatan yang berbeda.

b. Pembentukan Tim Terdiri dari:

1 Ketua Tim PKBRS adalah seorang dokter spesialis Obgyn, 1 orang sekretaris, dan 3 orang anggota

c. Program rotasi:

Program rotasi tim PKBRS dilaksanakan untuk pembinaan SDM

d. SIP, SIB DAN SIK

Tim PKBRS secara keseluruhan sudah memiliki SIP, STR maupun SIK yang masih berlaku.

3.1.3 Rencana tindak lanjut :

Kordinasi dengan BKKBN untuk mengembangkan pelayanan. Serta melakukan pelatihan eksternal terkait keluarga berencana.

No	Kegiatan Pokok SDM	Pemenuhan Rencana Kegiatan
1	Kebutuhan SDM	Tidak ada perubahan anggota tim KBR
2	Orientasi	Tidak ada anggota baru
3	Pendidikan dan Pelatihan	Terdapat pelatihan internal untuk semua bidan RS PHM pada bulan Juni 2025
4	Evaluasi Kinerja	a. Ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB. b. Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB c. Ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan standart PKBR d. Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP e. Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. f. Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.

3.2 Pengembangan Pelayanan

Pada tahun ini ada pelayanan baru dalam bidang Keluarga Berencana Rumah Sakit, yang sebelumnya KB hanya dilakukan oleh dokter kandungan karena permintaan pasien yang hanya minta dilayani oleh dokter kandungan dan saat ini terdapat pelayanan Keluarga Berencana oleh Bidan kompeten yang dilakukan sesuai jadwal.



**RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA**

KONSULTASI & LAYANAN KB

**RS PRIMA HUSADA
MALANG**

POLI KIA LT 2
senin-jumat jam 11.00-13.00

MELAYANI :

- ✓ IUD BKKBN (IUD COPPER - T)
- ✓ KB PIL
- ✓ KB SUNTIK 3 BULAN
- ✓ KONDOM
- ✓ IMPLAN

SYARAT AKSEPTOR IUD:

- Pastikan tidak sedang hamil
- IUD dipasang pada saat haid hari ke 2-5
- Tidak ada nyeri haid
- Setelah melahirkan normal / tidak operasi Caesar

SYARAT ADMINISTRATIF:

- Fotokopi KTP suami & istri masing - masing 1 lembar
- Fotokopi KK 1 lembar
- KK suami dan istri jadi 1

CONTACT PERSON:
0896-0696-2515

"Sahabat Menuju Sehat"
(0341) 458679 | 08113492244
Jl. Banjararum Selatan 3-9 Mondoroko Singosari-Malang

rs-primahusada.com | @rsprimahusada_malang

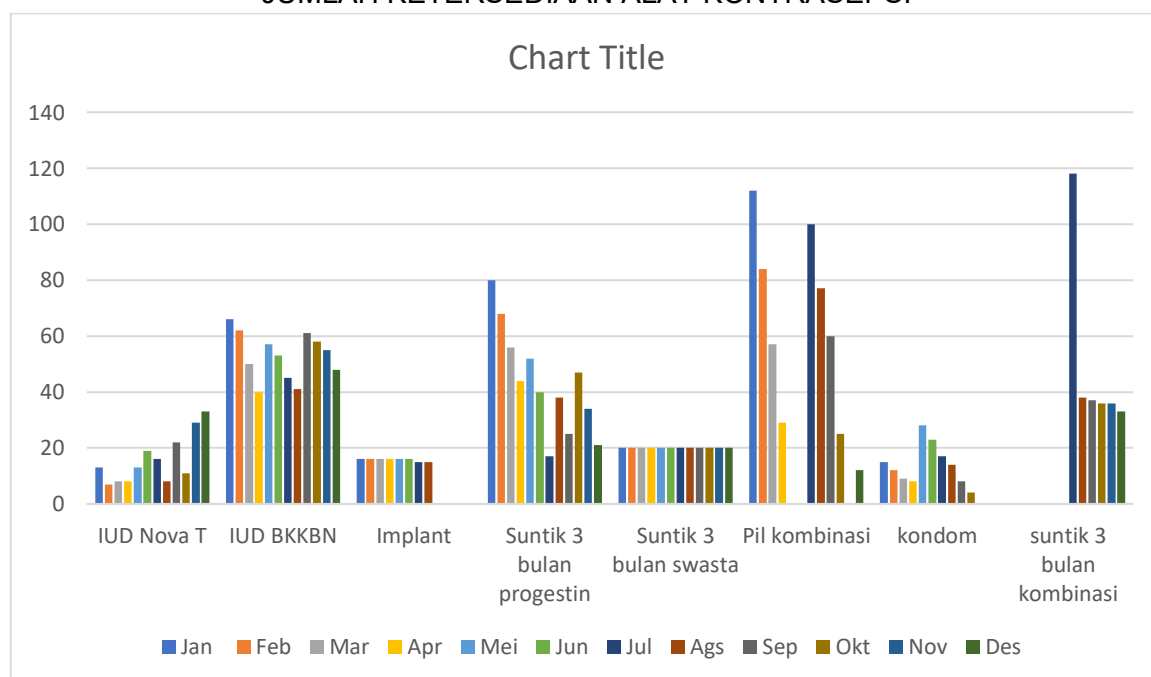
No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.	Tersedianya semua jenis alat dan Obat kontrasepsi meliputi : a. KB MOW b. KB IUD c. KB Implant d. KB Pil e. KB Suntik 3 Bulan f. KB Kondom
2	Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.	Tersedianya Poli Kesehatan Ibu dan Anak Tersedianya Poli Obstetri dan Ginekologi Tersedianya Ruangan Operasi 24 jam
3	Ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB	Adanya Tim PKBRS
4	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.	Capaian Indikator Mutu Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit
5	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	
6	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.	
7	Rapat koordinasi dengan pimpinan Rumah Sakit	- Ketersediaan anggaran program Tim PKBRS (pelatihan sosialisasi , fasilitas, APD) - Bukti laporan pelaksanaan program Tim PKBRS : direktur, kepala bidang, divisi, kepala unit pelayanan , ketua anggota Tim PKBRS

3.3 Kinerja Produktifitas

3.3.1 Jumlah ketersediaan alat kontrasepsi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah alat kontrasepsi											
		Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25	Jul 25	Ags 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Des 25
1	MOW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IUD NOVA T	13	7	8	8	13	19	16	8	22	11	29	33
3	IUD BKKBN	66	62	50	40	57	53	45	41	61	58	55	48
4	IMPLANT BKKBN	16	16	16	16	16	15	15	15	0	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN Progestin	80	68	56	44	52	40	17	38	25	47	34	21
6	SUNTIK 3 BULAN SWASTA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7	PIL kombinasi	112	84	57	29	0	0	100	77	60	25	0	12
8	KONDOM BKKBN	15	12	9	8	28	23	17	14	8	4	0	0

GRAFIK 1
Jumlah ketersediaan alat kontrasepsi



Evaluasi :

1. Pada Bulan Januari stok alat kontrasepsi masih banyak
2. Pada Bulan Februari stok alat kontrasepsi masih banyak
3. Pada Bulan Maret stok alat kontrasepsi masih banyak
4. Pada Bulan April stok alat kontrasepsi menipis sudah pengajuan ke BKKBN
5. Pada Bulan Mei mendapat kiriman dari BKKBN suntik 3 bulan progestin sebanyak 20 pcs,IUD BKKBN 25 pcs dan kondom 2 gross,pil KB kombinasi stok habis tapi dari Gudang BKKBN masih kosong,jadi stok pil KB Kombinasi sementara kosong
6. Pada bulan Juni stok alkon masih banyak,dilakukan pengajuan pil KB kombinasi karena stok kosong gudang BKKBN
7. Pada bulan Juli ada pengiriman dari BKKBN yaitu suntik kombinasi sebanyak 20 dan pil kombinasi sebanyak 100 pcs,suntik Progestin sisa 17 vial rencana pengajuan stok k BKKBN
8. Pada Bulan Agustus Suntik kombinasi dialihkan ke faskes lain karena terlalu banyak sebanyak 80 vial,ada tambahan stok suntik 3 bulan progestin sebanyak 40 vial
9. Pada Bulan September ada kiriman IUD copper T dari BKKBN sebanyak 25,stok implan sebanyak 15 pcs dimusnahkan karena sudah penerimaan barang IUD Nova T sebanyak 20 pcs
10. Pada bulan Oktober ada penerimaan suntik KB dari BKKBN sebanyak 40 vial,untuk stok pil KB dan kondom menipis direncanakan pengajuan alkon k BKKBN untuk bulan November
11. Pada bulan November stok kondom dan pil kb habis,sudah pengajuan ke BKKBN tapi belum dikirim
12. Pada bulan Desember belum ada pengiriman dari BKKBN tapi mendapat pengalihan alkon dari faskes lain yaitu pil KB sebanyak 40 strip

Analisis :

Penambahan jenis alat kontrasepsi dilakukan jika jumlah alat kontrasepsi sudah mencapai stok minimal

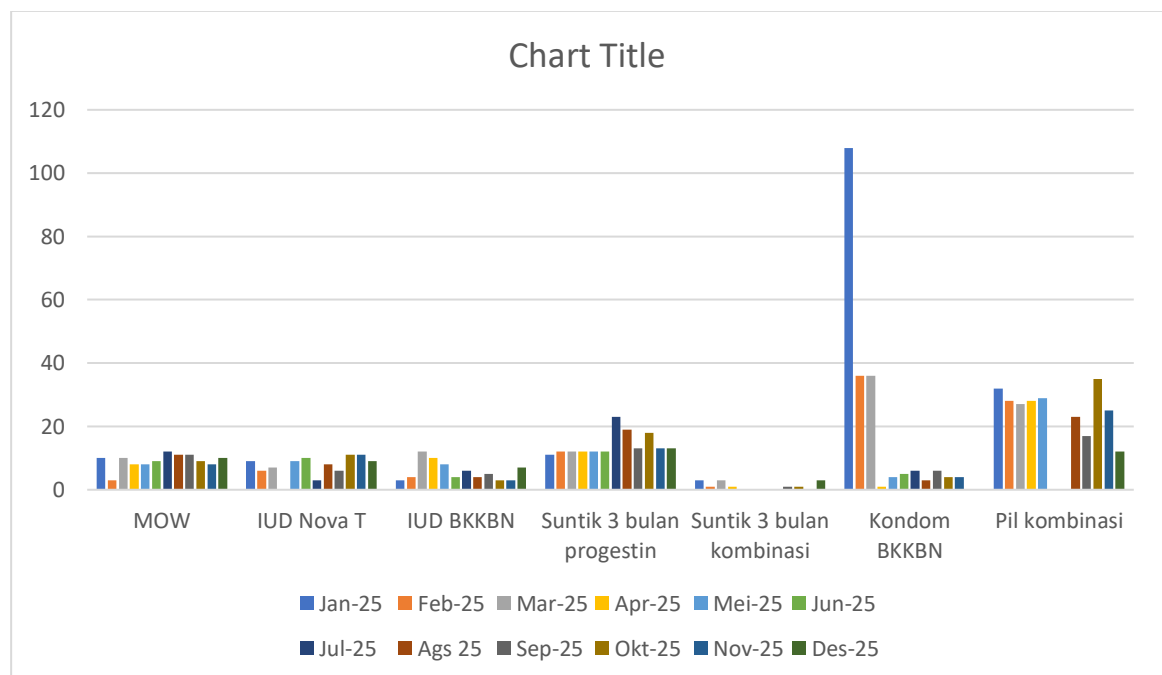
Rencana tindak lanjut :

Mengajukan alat kontrasepsi yang sudah mendekati stok minimal agar tidak sampai terjadi kekosongan barang

3.3.2 Capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien											
		Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25	Jul 25	Ags 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Des 25
1	MOW	10	3	10	8	8	9	12	11	11	9	8	10
2	IUD Nova T	9	6	7	0	9	10	3	8	6	11	11	9
3	IUD BKKBN	3	4	12	10	8	4	6	4	5	3	3	7
4	IMPLANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	11	12	12	12	12	12	23	19	13	18	13	13
6	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	32	28	27	28	29	0	0	23	17	35	25	12
9	KONDOM BKKBN	108	36	36	1	4	5	6	3	6	4	4	0

GRAFIK 2
CAPAIAN PELAYANAN KB PER METODE KONTRASEPSI



Evaluasi :

1. Peserta MOW pada bulan Januari (10) Februari (3) naik Maret (10)
2. Peserta IUD Nova T pada bulan Januari (9) Februari (6) Maret (7)
3. Peserta IUD BKKBN Januari (3) naik Februari (4) Maret (12)
4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Januari (3) turun Februari (1) naik Maret (3)
5. Peserta KB suntik progestin Januari (11) naik Februari (12) Maret tetap (12)
6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Januari (32) turun Februari (28) Maret (27)
7. Peserta KB Kondom pada bulan Januari (108) menurun Februari (36) Maret tetap (36)
8. Peserta MOW pada bulan April turun (8)Mei tetap(8) Juni naik (9)
9. Peserta IUD Nova T pada bulan April turun (0) Mei naik(9) Juni (10)
10. Peserta IUD BKKBN April turun (10) Mei (8) Juni (4)
11. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan April turun (1) Mei (0) Juni(0)
12. Peserta KB suntik progestin April tetap (12) Mei tetap(12) Juni (12)
13. Peserta KB pil kombinasi pada bulan April (28) Mei naik (29) Juni (0)
14. Peserta KB Kondom pada bulan April turun (1) Mei naik(4) Juni (5)
15. Peserta MOW pada bulan Juli naik (12) Agustus (11) September tetap (11)
16. Peserta IUD Nova T pada bulan Juli turun (3) Agustus naik (8) September turun (6)
17. Peserta IUD BKKBN pada bulan Juli naik (6) Agustus (4) September naik (5)
18. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Juli (1) Agustus dioperkan ke faskes lain sebanyak 80 vial,September (1)
19. Peserta KB suntik progestin pada bulan Juli naik (23) Agustus dipakai sebanyak (19) dioperkan ke faskes lain sebanyak (10) vial September turun (13)
20. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Juli (0) Agustus (23) September turun (17)
21. Peserta KB Kondom pada bulan Juli (6) turun Agustus (3) September naik (6)
22. Peserta MOW pada bulan Oktober (9) pada November turun (8) pada Desember naik (10)
23. Peserta IUD Nova T pada bulan Oktober naik (11) pada November tetap 11 pada Desember turun (9)
24. Peserta IUD BKKBN pada bulan Oktober turun (3)November tetap (3) Desember naik (7)
25. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Oktober tetap (1) November turun (0) Desember naik (3)
26. Peserta KB suntik progestin pada bulan Oktober naik (18) November turun (13) Desember tetap (13)
27. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Oktober naik (35) November turun (25) karena stok habis dan Desember naik (28)

-
28. Peserta KB Kondom pada bulan Oktober turun (4) November tetap (4) Desember turun karena stok habis (0)

Analisis:

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. Meningkatkan keterampilan bidan dalam pemasangan IUD pasca persalinan
5. Rutin dilakukan safari KB

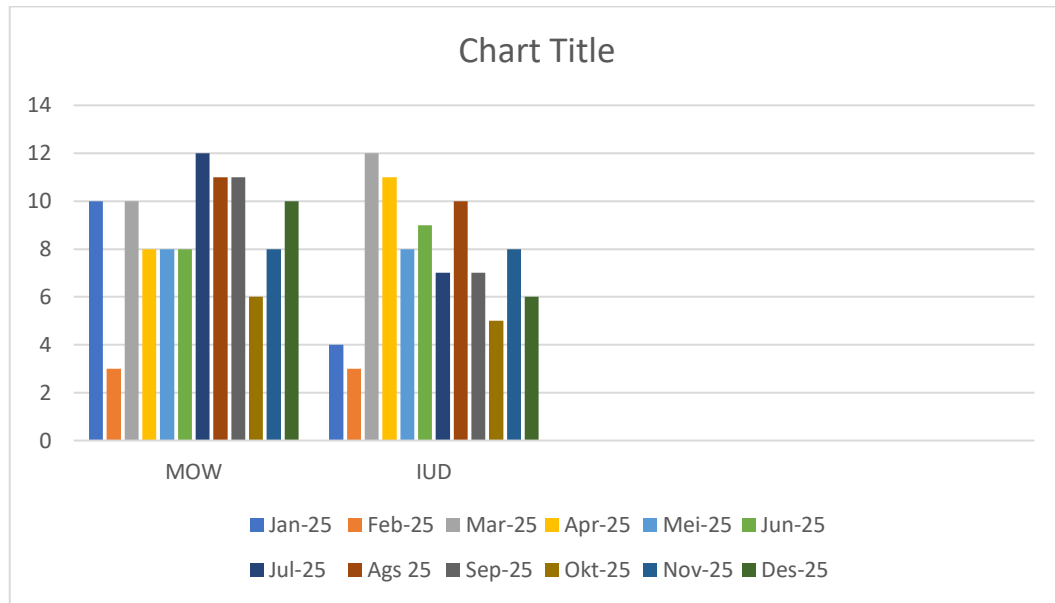
Rencana tindak lanjut :

Dengan adanya riwayat kekosongan barang dari pabrik,sebaiknya tim Gudang farmasi menambah stok minimal barang sehingga tidak terjadi lagi kekosongan jumlah barang

3.3.3 Capaian pelayanan KB Pasca persalinan dan pasca keguguran

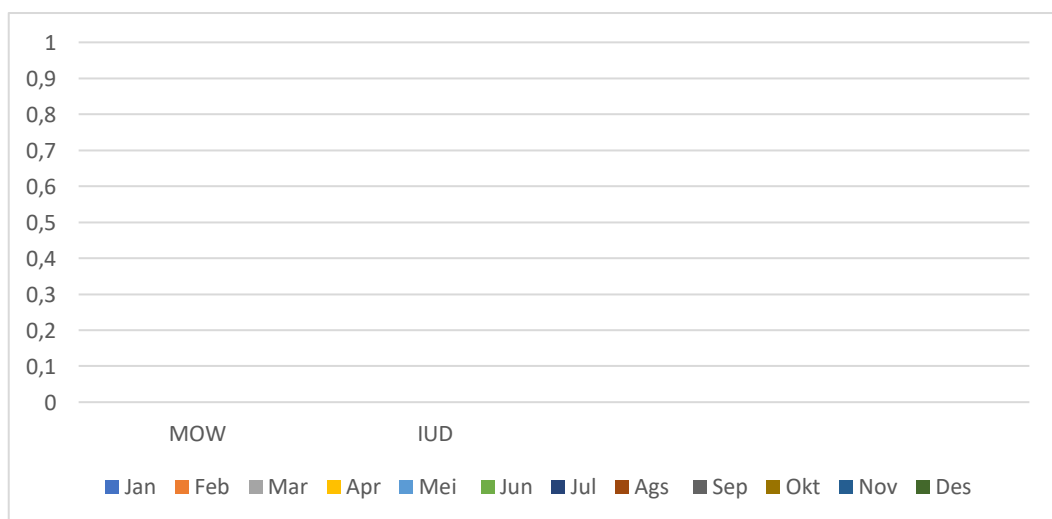
No	Jenis Pelayanan pasca persalinan	Jumlah Pasien											
		Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25	Jul 25	Ags 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Des 25
1	MOW	10	3	10	8	8	8	12	11	11	6	8	10
2	IUD	4	3	12	11	8	9	7	10	7	5	8	6

GRAFIK 3
Capaian pelayanan KB Pasca persalinan



No	Jenis Pelayanan pasca Keguguran	Jumlah Pasien											
		Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25	Jul 25	Ags 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Des 25
1	MOW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Capaian pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran



Evaluasi

Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dan penurunan setiap bulannya.

Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada tahun 2025 mengalami peningkatan dan penurunan setiap bulannya.

Analisis

Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan ketiga kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.

Capaian pelayanan KB pasca keguguran juga mengalami peningkatan dan penurunan dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Melakukan tindakan KB post nifas dan post keguguran di rumah sakit
2. Melakukan edukasi dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
3. Perlunya meningkatkan fungsi rumah sakit dalam mengedukasi pentingnya ber KB pada PUS.
4. Rutin melakukan penyuluhan pada setiap bulannya

3.4 Fasilitas Kesehatan

3.4.1 Sarana dan prasarana

No	Jenis	Lengkap	Jumlah	Kondisi
	Ruangan			
1	R. Tunggu & pendaftaran serta KIE Medis	√	tersedia	Baik siap pakai
2	R. Periksa & Pelayanan kontrasepsi	√	tersedia	Baik Siap Pakai
3	R. Operasi	√	tersedia	Baik siap pakai
4	R. Perawatan pasca bedah	√	tersedia	Baik Siap Pakai
5	R. Laboratorium lengkap	√	tersedia	Baik siap pakai
6	Toilet	√	tersedia	Baik Siap Pakai
	Peralatan Medis			
1	Meja ginekologi	√	1	Baik siap pakai

2	Tensimeter	√	1	Baik Siap Pakai
3	Stetoskop	√	1	Baik siap pakai
4	Implant kit	√	Sesuai alat	Baik Siap Pakai
5	IUD Kit	√	2	Baik siap pakai
7	Minilaparoskop kit	-	Tidak tersedia	
8	Laparoskop	-	Tidak tersedia	
9	Emergensi kit	√	tersedia	Baik siap pakai
10	Sterilisator	√	CSSD	Baik siap pakai
11	Alat suntik	√	tersedia	Baik Siap Pakai
12	Perlengkapan & obat secukupnya untuk yang kontap IUD, Implant, MOW	√	tersedia	Baik siap pakai
13	Histeroskop	-	Tidak tersedia	
14	Peralatan untuk rekanalisasi	-	Tidak tersedia	
15	Peralatan penanggulangan infertilitas	-	Tidak tersedia	

No	Jenis	Lengkap	jumlah	
	Peralatan Non Medis			
1	Timbangan BB	√	1	Baik Siap Pakai
2	Tempat tidur pemeriksaan	√	1	Baik siap pakai
3	Lampu sorot			
4	Bangku kecil untuk naik ke tempat Tidur	√	1	Baik Siap Pakai
5	Meja alat	√	1	Baik siap pakai
6	Wastafel	√	1	Baik Siap Pakai
7	Papan nama fasilitas pelayanan	√	1	Baik siap pakai
8	Lemari penyimpanan alokon	√	1	Baik Siap Pakai
	Media KIE & KIP / Konseling			
1	Poster	√	tersedia	Baik Siap Pakai

2	Lembar balik	√	tersedia	Baik Siap Pakai
3	Booklet	√	tersedia	Baik Siap Pakai
4	Kartu Informasi	√	tersedia	Baik Siap Pakai
5	Media elektronik	√	tersedia	Baik Siap Pakai

Evaluasi:

1. Secara umum kondisi fasilitas dan peralatan PKBRS cukup lengkap.
2. Apabila ada alat yang rusak akan diperbaiki oleh tim IPSRS.
3. Pada bulan Maret belum dilaksanakan kalibrasi karna kalibrasi hanya dilakukan pada bulan Juni dan November

Rencana Tindak Lanjut:

Koordinasi dengan bagian IPSRS untuk service alat tensimeter karena mengalami kerusakan ringan.

3.4.2 Keselamatan dan kesehatan kerja

a. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit agar terciptanya kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit perlu menerapkan SMK3 Rumah Sakit. SMK3 Rumah Sakit merupakan bagian dari sistem manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan.

b. Pengertian

Pengertian K3 Menurut Filosofi Mangkunegara, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

c. Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan kerja di RS Prima Husada
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
3. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
4. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

d. Tata Laksana Keselamatan Kerja

Mengacu pada pengertian tersebut maka diharapkan setiap petugas rumah sakit dapat menerapkan sistem keselamatan kerja diantaranya:

1. Petugas mengerti SPO penggunaan APD sehingga dapat menggunakan APD sesuai prosedur.
2. Tersedianya APD yang memenuhi standar.
3. Tersedianya tempat pembuangan sampah yang dibedakan infeksius dan non infeksius serta terdapatnya tempat khusus untuk pembuangan jarum atau pun spuit bekas.
4. Aturan untuk tidak melakukan recuping jarum suntik setelah dipakai ke pasien.
5. Setiap pasien yang menular atau beresiko menular di rawat di ruang isolasi.
6. Setiap petugas medis maupun non medis menjalankan prinsip pencegahan infeksi, yaitu:
 - a) Menganggap bahwa pasien maupun dirinya sendiri dapat menularkan infeksi
 - b) Menggunakan alat pelindung (hazmat/ skort, sarung tangan, kacamata, sepatu boot/ alas kaki tertutup, celemek, masker, dll) terutama bila terdapat kontak dengan spesimen pasien yaitu: urin, darah, muntah, sekret, dll
 - c) Melakukan tindakan yang aman bagi petugas maupun pasien, sesuai prosedur yang ada, misal : memasang kateter, menyuntik, menjahit luka, memasang infus, dll
 - d) Mencuci tangan dengan sabun antiseptik pada 5 momen.
7. Terdapat tempat sampah infeksius dan noninfeksius.
8. Mengelola alat dengan mengindahkan prinsip sterilitas, yaitu:
 - a) Dekontaminasi dengan larutan klorin
 - b) Pencucian dengan sabun
 - c) Pengeringan
9. Menggunakan baju kerja yang bersih

e. Prinsip Keselamatan Kerja

Dalam prinsip kesehatan keselamatan kerja (K3) secara utuh di rumah sakit ada 3 komponen penting yang saling berhubungan, antara lain :

1. Kapasitas kerja, kemampuan seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik pada suatu tempat kerja dalam waktu tertentu.
2. Beban kerja, suatu kondisi yang membebani pekerja baik secara fisik maupun non fisik dalam menyelesaikan pekerjaannya, kondisi tersebut dapat diperberat oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung secara fisik atau non fisik.
3. Lingkungan kerja, kondisi lingkungan tempat kerja yang meliputi factor fisik, kimia, biologi, ergonomic dan psikososial yang mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

3.5 Mutu

3.5.1 Angka capaian KB per metode kontrasepsi

n o	Pengukuran mutu	Standar	MO W	IUD Nov a T	IUD BKKB N	Suntik progesti n	Suntik kombina si	Pil kombina si	Pil lakta si	Hasil Kondo m
1	Angka capaian KB per metode kontrasepsi bulan Januari	100 %	5,68 %	5,11 %	1,70 %	6,25 %	1,70 %	18,18 %	0 %	61,36 %
2	Angka capaian KB per metode kontrasepsi bulan Februari	100%	3,3 %	6,6 %	1,1 %	13,3 %	1,1 %	31 %	0%	40 %
3	Angka capaian KB per metode kontrasepsi bulan Maret	100 %	9,3 %	6,54 %	11,2 %	11,2 %	2,8 %	25,2 %	0%	33,6 %
4	Angka capaian KB per metode kontrasepsi bulan April	100 %	11,2 %	0 %	14,8 %	16,9 %	1,4 %	39,4 %	0%	16,9 %
5	Angka capaian KB per metode kontrasepsi bulan Mei	100 %	7,01 5	7,89 %	7,01 %	10,52 %	0%	25,4%	0%	10,52 %
6	Angka capaian	100 %	8,02 %	9,01 %	6,7 %	12,8 %	0%	27,8 %	0%	12,3 %

	KB per metode kontrasepsi bulan Juni									
7	Angka capaian KB per metode kontrasepsi bulan Juli	100 %	19,67 %	4,9 %	6,89 %	54,09%	1,6 %	0 %	0%	9,8 %
8	Angka capaian KB per metode kontrasepsi bulan Agustus	100 %	18,96 %	13,79 %	6,89 %	15,5%	0 %	39,6 %	0%	5,17 %
9	Angka capaian KB per metode kontrasepsi bulan September	100 %	18,6 %	10,01 %	8,47 %	22 %	1,69 %	28,8 %	0%	10,1 %
10	Angka capaian KB per metode kontrasepsi bulan Oktober	100 %	8,3 %	15,2 %	4,1 %	25 %	1,3 %	48,6 %	0 %	5,5 %
11	Angka capaian KB per metode kontrasepsi bulan November	100 %	12,5 %	17,2 %	4,6 %	20,3 %	0 %	39 %	0 %	6,25 %

1	Angka	100 %	18, %	16,6	12,9	24 %	5,5 %	22,2 %	0 %	
2	capaian KB per metode kontrase psi bulan Desemb er		%	%	%					

3.5.2 Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan

no	Pengukuran mutu	Standar	Hasil MOW	Hasil IUD
1	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan bulan Januari	100 %	8,77 %	3,50 %
2	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan bulan Februari	100 %	6,1 %	8,16 %
3	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan bulan Maret	100 %	9,8 %	11,76 %
4	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan bulan April	100 %	16,32 %	22,4%
5	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan bulan Mei	100 %	7,61 %	7,61 %
6	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan bulan Juni	100 %	9,84%	10,6%
7	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan bulan juli	100 %	12 %	7 %
8	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan bulan Agustus	100 %	9%	8,26 %
9	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan bulan September	100 %	9,09 %	5,78 %
10	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan bulan Oktober	100 %	5,12 %	4,27 %
11	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan bulan November	100 %	7,84 %	7,84 %
12	Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan bulan Desember	100 %	7,9 %	4,7 %

3.5.3 Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran

no	Pengukuran mutu	standar	Hasil MOW	Hasil IUD
1	angka capaian KB pelayanan KB pasca keguguran bulan Januari	100 %	0 %	0 %
2	angka capaian KB pelayanan KB pasca keguguran bulan Februari	100 %	0 %	0 %
3	angka capaian KB pelayanan KB pasca keguguran bulan Maret	100 %	0 %	0 %
4	angka capaian KB pelayanan KB pasca keguguran bulan April	100 %	0 %	0 %
5	angka capaian KB pelayanan KB pasca keguguran bulan Mei	100 %	0 %	0 %
6	angka capaian KB pelayanan KB pasca keguguran bulan Juni	100 %	0 %	0 %
7	angka capaian KB pelayanan KB pasca keguguran bulan Juli	100 %	0 %	0 %
8	angka capaian KB pelayanan KB pasca keguguran bulan Agustus	100%	0 %	0 %
9	angka capaian KB pelayanan KB pasca keguguran bulan September	100 %	0 %	0 %
10	angka capaian KB pelayanan KB pasca keguguran bulan Oktober	100 %	0 %	0 %
11	angka capaian KB pelayanan KB pasca keguguran bulan November	100 %	0 %	11,1 %
12	angka capaian KB pelayanan KB pasca keguguran bulan Desember	100 %	0 %	0 %

3.5.4 Kejadian tidak dilakukannya KB pasca persalinan

No	Jenis Pelayanan pasca persalinan	Jumlah Pasien											
		Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25	Jul 25	Ags 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Des 25
1	MOW	104	48	92	41	97	91	100	110	110	111	94	116
2	IUD	110	45	90	38	97	91	106	111	114	112	94	120

3.5.5 Kejadian tidak dilakukannya KB pasca keguguran

No	Jenis Pelayanan pasca Keguguran	Jumlah Pasien											
		Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25	Jul 25	Ags 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Des 25
1	MOW	17	18	19	9	13	15	12	5	15	15	9	7
2	IUD	17	18	19	9	13	15	12	5	15	15	8	7

Evaluasi : Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, pelayanan KB pasca persalinan, pelayanan KB pasca keguguran masih rendah.

Analisa :

1. Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi setiap bulannya mengalami peningkatan dan penurunan
2. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran pada tahun 2025 masih rendah.
3. Kejadian tidak dilakukannya KB pasca Persalinan dan Pasca keguguran pada ibu baru bersalin dan ibu pasca keguguran masih sangat tinggi.
4. Nomer 1,2,3 kemungkinan disebabkan karena pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) masih membayar, sedangkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) bisa dilakukan secara gratis, sehingga pasien memilih melakukan pelayanan KB di FKTP dan pasien pasca keguguran ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. Meningkatkan keterampilan bidan dalam pemasangan IUD pasca persalinan
5. Rutin dilakukan safari KB

Bed gynecologi	1
Alat TTV	Tensi 1,termogun 1,stetoskop 1
Timbangan berat badan dewasa	1
Meja	1
Lampu sorot	1
Phantom rahim	1
ABPK	1

3.6 Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan

Kebersihan tangan merupakan hal yang paling penting untuk mencegah penyebaran infeksi. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun harus segera dilakukan terutama saat tangan terlihat kotor atau terkontaminasi dengan bahan-bahan dari tubuh pasien. Penggunaan handrub dengan bahan alkohol dapat dilakukan secara rutin untuk memastikan tangan bebas dari kontaminasi atau hanya jika tangan tidak terlihat kotor, bukan menggantikan fungsi cuci tangan. Lakukan cuci tangan pada momen yang tepat, yaitu :

- a. Sebelum kontak langsung dengan pasien.
- b. Setelah kontak langsung dengan pasien.
- c. Sebelum melakukan tindakan invasif pada pasien.
- d. Setelah terkena cairan tubuh pasien.
- e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien

6 langkah cuci tangan menggunakan handwash sebagai berikut :

- a. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih (kran, air yang dituangkan dari wadahnya mengaliri tangan). Ambil 3-5cc sabun cair, ratakan dengan kedua telapak tangan.
- b. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan jari-jari tangan kanan dan sebaliknya.
- c. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua telapak tangan.
- d. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci.
- e. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggam tangan kanan dan sebaliknya.
- f. Gosok arah berputar ujung-ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya.
- g. Bilas kedua tangan dengan air mengalir.
- h. Keringkan dengan handuk sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering.
- i. Tutup kran dengan handuk sekali pakai atau tisu

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Skedul (jadwal) kegiatan tersebut akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali melalui rapat TIM PKBRS, bila dari evaluasi diketahui ada pergeseran/penyimpangan jadwal dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu program secara keseluruhan. Evaluasi skedul (jadwal) kegiatan tersebut dilakukan oleh ketua Tim PKBRS

Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan mencakup bagaimana laporan tersebut dibuat, oleh siapa dan kapan laporan tersebut dibuat serta ditujukan kepada siapa laporan tersebut

BAB IV

PENUTUP

Pelayanan keluarga berencana Rumah sakit adalah bagian pelayanan dari Rumah Sakit Prima Husada yang memberikan pelayanan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Dengan adanya pedoman pelayanan keluarga berencana rumah sakit diharapkan dapat membantu dalam memberikan pelayanan khususnya tim PKBRS dan dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh staf rumah sakit terutama PPA dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Sehingga asuhan pelayanan pasien dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan yang berdampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan pasien karena kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Prima Husada.

Yang Membuat Laporan,
Ketua tim KBR



dr. Humaira Rahma, Sp. OG

Malang 09 Januari 2026
Mengetahui



dr. Resti Lestantini, M. Kes